

시험 광경 코멘트



객혈은 하기도 출혈에 의해 기침과 함께 혈액이 섞인 가래가 나오는 증상입니다. 가장 먼저 출혈 부위가 하기도가 맞는지, 비강, 구강, 위장관 등 다른 부위가 아닌지 감별하는 질문이 필요합니다. 따라서 출혈의 **색깔**, 어떠한 **상황**에서 객혈하였는지, **양** 등은 꼭 확인해야 합니다. 객혈은 보통 기침에 의해 유발되고, 선홍색을 띕니다. 환자가 놀랐을 가능성이 크므로 안심시키는 것도 환자-의사 관계에서 점수를 받는 데에 도움이 됩니다.

응급 상황인지, 출혈 경향이 있는지 확인하고, **대량 객혈이 발생한 경우 출혈 부위가 아래로 가도록 옆으로 비스듬히 누워 혈액이 기도를 막지 않도록 조치**함과 동시에 최대한 빨리 내원하여 지혈 치료를 받도록 교육하여야 할 것입니다.

폐결핵, 기관지확장증은 자주 나오는 원인이므로 잘 정리해 두어야 합니다. **결핵과 같은 법정 감염병의 경우 자가 격리가 필요함**을 설명하도록 합니다. 감염성의 경우 손위생의 중요성을 잘 교육해야 합니다.

만성 흡연자, 체중 감소, 고령 등이 주어지는 경우 가장 의심되는 질환은 폐암입니다. 환자가 놀랄 수 있기 때문에 직접적으로 폐암이라고 말하기보다는 의심되는 질환이 여러 개 있으니 조심스럽게 얘기를 꺼내는 것이 좋습니다.

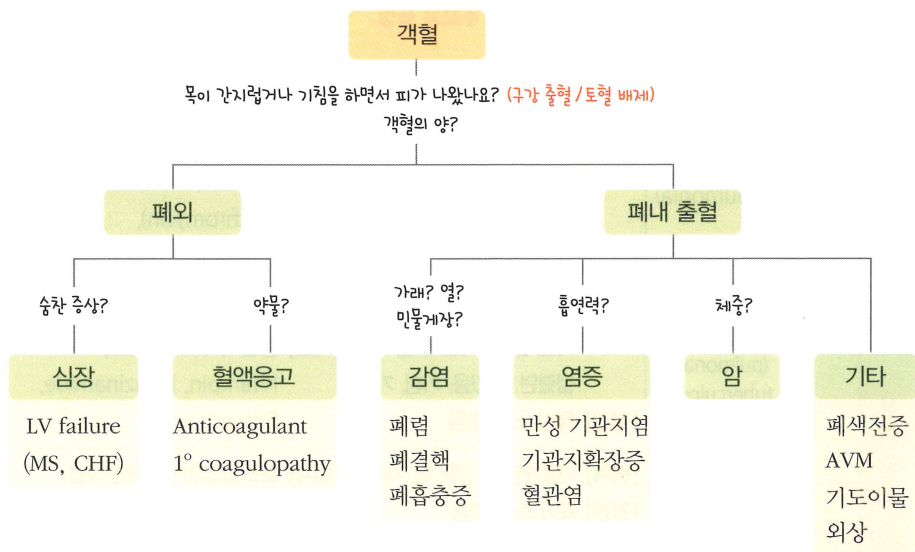
영상검사가 필요하고 추가로 조직검사를 진행해야 할 수도 있습니다. 만약 폐암이 아니더라도 흡연은 호흡기 질환의 근원이기 때문에 교육에서 금연을 언급하는 것 역시 중요합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
상기도(기타)		상기도/ 단순 구강 출혈	[병력] 양치 중 출혈, 소량의 피 [검진] 구강 시전에서 피가 확인됨	[검사] 불필요 [치료] 경과 관찰
하기도	염증 / 감염	만성 기관지염★ (chronic bronchitis)	[병력] 잦은 기침, 소량의 피, 가래 [검진] 특이 소견 없음	[검사] CXR, CBC, 객담배양검사 [치료] 항생제, 진해제, 필요 시 기도확장제

하 기 도	염 증 / 감 염	기관지확장증★ (bronchiectasis) (대량)	[병력] 잦은 상기도 감염의 병력, 가래, 많은 양의 피가 확인 [검진] 폐 청진 시 수포음 들릴 수 있음	[검사] CXR, 흉부 CT [치료] 기관지동맥색전술, 폐절제술
		폐렴 (pneumonia)	[병력] 발열, 기침, 가래, 흉통 [검진] 폐 청진 시 수포음, 타진음 증가, 성음진탕 증가	[검사] CXR, 혈액/객담 배양, CBC [치료] 경험적 항생제 (Fluoroquinolone, Azithromycin), 수액 공급
		폐결핵★ (pulmonary tuberculosis)	[병력] 발열, 체중 감소, 피로, 야간 발한, 이전에 결핵 걸렸던 적 있음, 기침, 가래 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 투베르쿨린검사, 객담 항산염색 [치료] 항결핵제 (Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide, Ethambutol)
		폐흡충증★ (paragonimiasis)	[병력] 민물게장, 패 많은 피, 가래 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 효소결합면역흡착분석법 (ELISA) [치료] 프라지칸텔 (Praziquantel)
	혈관	폐색전증 (pulmonary embolism)	[병력] 갑작스러운 호흡곤란, 수술/외상력으로 계속 누워있는 병력, 흉통 [검진] 흉부 청진에서 수포음, 목정맥 확장, 사지 부종도 가능함	[검사] 흉부전산화단층촬영 (CT), 심전도, CT angiography [치료] 저분자량 헤파린, 응급 상황 시 혈전용해제, 하대정맥 필터 (IVC filter)
	종양	폐암★ (lung cancer)	[병력] 체중 감소, 패 많은 피, 오랜 흡연자 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 기관지내시경, 경피적 미세침 흡인술 (PerCutaneous needle aspiration) [치료] 폐절제술, 방사선 치료, 항암제
	소화기	식도정맥류 출혈 (esophageal varix bleeding)	[병력] 객혈이 아니고 토혈, 자세한 것은 토혈 참조	[검사] 위내시경 [치료] 베타 차단제, 내시경적 지혈술 등
	혈액	혈액응고장애 (hemostatic disorder)	[병력] 쉽게 멍이 들, 출혈 경향, 자세한 것은 '쉽게 멍이 들' 참조	[검사] 혈액응고검사 [치료] 질환에 따라 치료

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 객혈이 시작됐나요?
L	객혈이 발생할 때의 상황이 어땠나요? (구토, 기침, 양치)
D	한번 증상이 나타나면 얼마나 지속되나요? 하루에 몇 번이나 증상을 느끼시나요?
Co	증상이 점점 더 심해지는 것 같으세요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? → 치료는 받으셨나요?

C	[양/색/양상] 피를 토했을 때 양은 얼마나 되었나요? (종이컵?/스푼?/물어나온 정도?) 색은 붉은 선홍색이었습니까?/검붉은색이었습니까? 거품이 섞여 있었습니까? 음식물이 섞여 있었습니까? [정도] 일상 생활에 지장이 있나요? 암기법 CAT, 거품/음식 설명 객혈에서 피의 색깔(선홍색/검붉은색), 양(종이컵/스푼/물어나옴), 특성(거품, 음식물 유무)를 물어봅니다.
A	[전신] 발열/오한/체중 감소(→ 꼭 물어봅니다, 폐암)/피로 [탈수] 대량 객혈로 인해 두근거림/어지럼증/목마름이 있었나요? [출혈 경향] 양치할 때 잇몸에서 피/쉽게 멍이 들/피가 나면 잘 멈추지 않는 경우가 있나요? [호흡가상기도] 기침/가래(양상 : 언제부터, 색, 양)/콧물/인후통 [호흡가하기도] 호흡곤란(기관지확장증, 폐결핵)/야간 발한(결핵) [순환기] 흉통/어지럼증 [소화기] 복통/혈변/황달 암기법 “피가 잘 나서 두근거리고 어지럽고 살 빠졌어” + 상기도/하기도/전신 설명 애초에 피가 잘 나는 사람인지, 출혈로 인한 증상(두근거림, 어지럼증)을 꼭 물어봅니다.
F	최근 감기에 걸리셨나요? 어릴 적부터 감기에 잘 걸리시는 편인가요? 민물게장 섭취 여부/악화, 완화 요인
E	이전에 건강 검진/흉부 엑스선 사진 찍은 적이 있나요? 이전에 예방접종은 필요한 대로 다 잘 맞으셨나요?
외	[외상] 가슴을 다치신 적이 있나요? [수술] 최근 수술이나 장기 입원 등 못 움직이는 상황이 있었나요?
과	과거에 천식이나 결핵, 폐질환을 진단 받은 적이 있나요? 고혈압/당뇨/간질환은요?
약	복용 중인 약물이 있나요?/피를 묽게 하는 약(아스피린 등) 먹고 있나요?
사	음주는 하세요?/흡연은 하시나요? → 담배 복용량, 양 자세히 묻기 직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요?/근무 환경은 어떤가요?

가	가족 중에 고혈압, 당뇨, 고지혈증 가진 분이 있나요? 결핵, 폐암 등 기타 기관지, 폐질환을 가진 분이 있나요? 혈액응고 질환을 가지신 분이 있나요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 입★ : 구강 점막, 잇몸 출혈, 입인두 시진 3. 코★ : 코피, 후비 배농, 코점막궤양 → 비경 사용 4. 목 : 림프절 비대 5. 흉부 진찰★ : 시-촉-타-청 6. 사지 : 명, 점상 출혈 등 피부 병변 확인(출혈 경향)/하지 부종, 곤봉지, 청색증 ⊕ 혈액응고 질환 의심 시 누워서 복부 진찰 (간, 비장 비대)
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 안전 수혈 술기 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 기침에 피가 섞여 나와 많이 놀라셨겠습니다.
추정 진단 / 감별 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 객혈의 원인이 만성 기관지염과 같은 병 때문일 수도 있겠으나, 환자분의 흡연력과 나이를 고려해 보았을 때, 폐암의 가능성도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 혈액검사 후에 흉부 X-ray와 CT를 찍고, 필요 시 기관지내시경을 시행하도록 하겠습니다. 괜찮으신가요?
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있으니 너무 염려하지 마세요.

교육	[응급 상황인 대량 객혈의 위험성] 갑자기 종이컵 한 컵 분량 이상의 피를 토하신 경우에는 응급 상황일 수 있으니 바로 병원으로 오셔야 합니다(대량 객혈의 치료 : airway protection, decubitus position, intervention-Bronchial artery embolization, rigid bronchoscopy 등). [예방접종] 원래 기관지가 약한 편이므로 앞으로도 폐렴 예방접종이나 주기적으로 독감 예방 접종을 하시는 것이 증상 완화에 도움이 될 것입니다. [금연 권유] 담배를 통해 유해 가스가 폐로 들어가게 되면, 잦은 기침을 유발하여 불편할 뿐 아니라 폐암이나 만성 폐쇄 폐질환과 같은 심각한 폐질환을 일으킬 수 있습니다. 이번 기회에 금연을 하시는 것은 어떨까요? [결핵의 경우] 법정 감염병에 해당하므로 격리 치료가 꼭 필요합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?
치료	검사 이후 결과에 따라 수술이 필요할 수도 있겠습니다.
	내과적 치료 정상 X선 사진, 기관지염의 전형적인 병력, 폐암 위험 인자(-) : 기관지염 치료 다른 폐질환의 악화를 시사하는 증상 (발열, 오한, 야간 발한, 호흡곤란, 전신 쇠약) 없는 환자에서 경도의 객혈을 보이는 경우 특별한 치료 없이 주의깊게 관찰 기침약(codeine)으로 기침을 부분적으로 억제하되 완전히 기침을 억제하면 안 된다.
	중재적 수술 [대량 객혈의 치료] Airway protection, Decubitus position(출혈 보이는 폐가 아래로 오도록), 응급 CBC, IV line, CXR [기관지내시경] Balloon tamponade 기관지 내 전기소작술(레이저) [기관지동맥색전술] 대량 객혈 환자의 일차적 치료 방법 [수술적 절제] 국소적 기관지확장증, 동정맥 기형, 대동맥류 누출, Fungal ball 등

❖ 기본적 진단 계획

- ① Chest X-ray, Chest CT
- ② 기관지내시경
- ③ 혈액검사 : CBC, Electrolyte, LFT, 혈액응고검사
- ④ Sputum culture, AFB stain, Tuberculin skin test, PFT

❖ 치료 계획

• 안정, 진해제, 지혈제, 원인 질환 치료

- ① 기관지확장증 : 체위배농, 항생제, 거담제
- ② 결핵 : 6개월 항결핵제 요법(2HERZ + 4HER)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 금연과 독감 예방접종의 중요성을 설명
- ② 응급 상황에 대한 교육 : 객혈의 양이 많은 경우(어지럼, 두근거림 등의 증상 시)나 폐색전증은 응급 조치가 필요하므로 병원에서 수액 공급 등 활력 징후를 안정시키기 위한 조치가 필요함을 설명

☞ 자택에서 대량 객혈 시 출혈 부위를 알 수 없으니 한쪽으로 눕지 마시고, 구급차 불러서 최대한 빨리 내원하세요.

- ③ 결핵과 같은 법정 감염병의 경우에는 외부 출입을 자제하며, 격리 치료가 필요할 수 있음을 설명
- ④ 손위생의 중요성을 강조
- ⑤ 무리한 운동 당분간 금지, 호흡기 자극할 만한 차가운 공기, 매연 피하기



keyword

객혈을 다른 부위(토혈, 비강, 구강 출혈 등)와 감별하기

객혈의 상황, 양, 색깔 파악하기

객혈의 가장 흔한 원인은 기관지염과 기관지원성 암중

대량 객혈의 가장 흔한 원인은 폐결핵과 기관지확장증

만성 흡연력, 고령, 체중 감소 등의 단서가 있으면 폐암 의심

폐결핵이 의심되면 자가 격리가 필요할 수 있음을 설명하기

대량 객혈인 경우 필요한 조치 숙지하기

금연 교육하기, 객혈의 양이 많으면 응급 상황일 수 있음을 교육하기